ORIGEM DO DOCUMENTO:	Núcleo de Segurança do Paciente		
TÍTULO:			**Nº DOC:**
Meta 4 – Protocolo de Cirurgia Segura			PRT.NSP.001
DATA 1ª VERSÃO	**DATA DESTA VERSÃO**	**VERSÃO Nº**	**PRÓXIMA REVISÃO**
10/12/2025	10/12/2025	01	10/12/2027

1. OBJETIVO

O Objetivo deste protocolo é determinar as medidas a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, no local correto e no paciente correto, por meio do uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde – OMS e ajustada a realidade da FCECON.

2. ABRANGÊNCIA

O protocolo para Cirurgia Segura deverá ser aplicado em todos os pacientes que se submeterem a procedimentos, quer terapêuticos, quer diagnósticos, que impliquem em incisão no corpo humano ou em introdução de equipamentos endoscópios, dentro ou fora de centro cirúrgico, por qualquer profissional de saúde da FCECON.

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

Nas últimas décadas, as técnicas cirúrgicas foram bastante aperfeiçoadas, aumentando as oportunidades de tratamento de patologias complexas. No entanto, esses

avanços também aumentaram, de modo expressivo, o potencial de ocorrência de erros que podem resultar em dano para o paciente e levar à incapacidade ou à morte.

Recentemente, o *Protocolo para Cirurgia Segura* foi estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS) com a finalidade de determinar as medidas a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, no local correto e no paciente correto, por meio do uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura (LVSC).

O objetivo dessa Lista de Verificação é fortalecer as práticas de segurança aceitas e promover a melhor comunicação e o trabalho efetivo da equipe multidisciplinar. A Lista de Verificação consiste em uma ferramenta para ser usada pelos profissionais para aumentar a segurança das cirurgias e reduzir óbitos e complicações cirúrgicas desnecessários.

O objetivo do protocolo é oferecer diretrizes para aumentar a segurança nos procedimentos cirúrgicos, além de abordar questões importantes de segurança, incluindo as práticas de segurança anestésicas inadequadas, infecções de sítio cirúrgico preveníveis e a má comunicação entre membros da equipe. Estes têm sido, comprovadamente, os problemas comuns, mortais e evitáveis em todos os países e contextos.

4. DEFINIÇÕES

- **Lista de Verificação:** Lista formal utilizada para identificar, comparar e verificar um grupo de itens/procedimentos.
- **Demarcação de Lateralidade:** demarcação de local ou locais a serem operados. Esta demarcação é particularmente importante em casos de lateralidade (distinção entre direita e esquerda), estruturas múltiplas (p.ex. dedos das mãos e dos pés, costelas) e níveis múltiplos (p.ex. coluna vertebral).
- **Condutor da Lista de Verificação:** profissional de saúde (médico ou profissional da enfermagem), que esteja participando da cirurgia e seja o responsável por conduzir a aplicação da lista de verificação, de acordo com

diretrizes da instituição de saúde**.**

- **Segurança Anestésica:** conjunto de ações realizadas pelo anestesiologista, que visa à redução da insegurança anestésica por meio da inspeção formal do equipamento anestésico, da checagem dos medicamentos e do risco anestésico do paciente antes da realização de cada cirurgia. Este procedimento deve seguir as orientações contidas no Manual para Cirurgia Segura da OMS, traduzido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
- **Equipe cirúrgica:** equipe composta por cirurgiões, anestesiologistas, profissionais de enfermagem, técnicos e todos os profissionais envolvidos na cirurgia.

5. CITÉRIOS DE INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO

Muitos fatores concorrem para que um procedimento cirúrgico seja realizado de forma segura: profissionais capacitados, ambiente, equipamentos e materiais adequados para a realização do procedimento, conformidade com a legislação vigente, entre outros. Entretanto, este protocolo trata especificamente da utilização sistemática da Lista de Verificação de Cirurgia Segura como uma estratégia para reduzir o risco de incidentes cirúrgicos. Baseia-se na Lista de Verificação de Cirurgia Segura e no Manual de Cirurgia Segura, desenvolvidos pela OMS.

Princípios de cirurgia segura.

A Lista de Verificação divide a cirurgia em três fases:

I - Antes da indução anestésica;

II - Antes de iniciar a cirúrgica; e

III - Antes do fechamento cirurgia e antes do paciente sair da sala

Cada uma dessas fases corresponde a um momento específico do fluxo normal de um procedimento cirúrgico. Para a utilização da Lista de Verificação, uma única pessoa deverá ser responsável por conduzir a checagem dos itens, que deverá ser o enfermeiro assistencial do corredor. Em cada fase, o condutor da Lista de Verificação deverá confirmar se a equipe completou suas tarefas antes de prosseguir para a próxima etapa. **Caso algum item checado não esteja em conformidade, a verificação deverá ser interrompida e o paciente mantido na sala de cirurgia até a sua solução.**

5.1. Antes da indução anestésica:

O condutor da Lista de Verificação deverá:

5.1.1. Revisar verbalmente com o próprio paciente, sempre que possível, que sua identificação (nome completo, data do nascimento e nome da mãe completo) tenha sido confirmada.

5.1.2. Confirmar se o procedimento e o local da cirurgia estão corretos.

5.1.3. Confirmar o consentimento para cirurgia e a anestesia.

5.1.4. Confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e sua demarcação.

5.1.5. Confirmar a conexão de um monitor multiparâmetro ao paciente e seu funcionamento.

5.1.6. Revisar verbalmente com o anestesiologista, o risco de perda sanguínea do paciente, dificuldades nas vias aéreas, histórico de reação alérgica e se a verificação completa de segurança anestésica foi concluída.

5.1.7. Confirmar reserva na UTI caso necessário

5.1.8. Verificar a antibioticoterapia em até 1 hora antes da incisão

5.1.9. Verificar possíveis alergias

5.2. Antes de iniciar a cirurgia (Pausa Cirúrgica)

Neste momento, a equipe fará uma pausa imediatamente antes da incisão cirúrgica para realizar os seguintes passos:

5.2.1. A apresentação de cada membro da equipe pelo nome e função.

5.2.2. A confirmação da realização da cirurgia correta no paciente correto, no sítio cirúrgico correto.

5.2.3. A revisão verbal, uns com os outros, dos elementos críticos de seus planos para a cirurgia, usando as questões da Lista de Verificação como guia.

5.2.4. A confirmação da administração de antimicrobianos profiláticos nos últimos 60 minutos da incisão cirúrgica.

5.2.5. A confirmação da acessibilidade dos exames de imagens necessários.

5.3. Antes do fechamento da cirurgia e Antes do Paciente sair da sala

A equipe deverá revisar em conjunto a cirurgia realizada por meio dos seguintes passos:

5.3.1. A conclusão da contagem de compressas e instrumentais.

5.3.2. A identificação de qualquer amostra cirúrgica obtida.

5.3.3. A revisão de qualquer funcionamento inadequado de equipamentos ou questões que necessitem ser solucionadas.

5.3.4. A revisão do prontuário.

6. PROCESSOS ENVOLVIDOS NA CIRURGIA SEGURA

A Cirurgia Segura é um conjunto de ações sistematizadas que visam reduzir riscos, prevenir eventos adversos e garantir a qualidade da assistência ao paciente cirúrgico. Esses processos envolvem avaliação multiprofissional contínua, desde o pré-operatório até o pós-operatório imediato e tardio.

6.1. Avaliação Pré-Operatória

6.1.1. Avaliação Cirúrgica

Realizada pelo cirurgião responsável, tem como objetivos:

- Confirmar o diagnóstico e a indicação cirúrgica;
- Definir o procedimento a ser realizado, técnica cirúrgica e lateralidade;
- Avaliar riscos e benefícios da cirurgia;
- Solicitar e analisar exames laboratoriais e de imagem pertinentes;
- Orientar o paciente e/ou familiar quanto ao procedimento, possíveis complicações e cuidados pós-operatórios;
- Garantir a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

6.1.2. Avaliação Anestésica

Realizada pelo anestesiologista, preferencialmente em consulta pré-anestésica, com foco em:

- Avaliação clínica completa e classificação do risco anestésico (ASA);
- Investigação de comorbidades, alergias, uso de medicamentos, jejum e histórico anestésico prévio;
- Definição da técnica anestésica mais adequada;
- Planejamento do controle da dor e cuidados no pós-operatório;
- Orientações específicas ao paciente, visando minimizar riscos anestésicos.

6.2. Avaliação da Enfermagem

6.2.1. Enfermagem no Pré-Operatório

A enfermagem atua de forma essencial na preparação do paciente, realizando:

- Identificação correta do paciente (pulseira de identificação);
- Conferência do procedimento, local e lateralidade;

- Verificação do jejum, exames, consentimentos e preparo cirúrgico;
- Avaliação clínica e registro de sinais vitais;
- Orientação ao paciente e familiares;
- Aplicação do checklist de Cirurgia Segura (etapa “Sign In”).

6.2.2 Enfermagem no Intraoperatório

Durante o procedimento cirúrgico, a equipe de enfermagem é responsável por:

- Garantir ambiente seguro, organizado e com materiais adequados;
- Manter a assepsia e a segurança do campo cirúrgico;
- Auxiliar no posicionamento correto do paciente, prevenindo lesões;
- Monitorar sinais vitais e condições clínicas;
- Participar ativamente da checagem de segurança (etapa “Time Out”);
- Realizar a contagem de compressas, instrumentos e perfurocortantes.

6.2.3. Enfermagem no Pós-Operatório

No pós-operatório imediato e mediato, a enfermagem:

- Monitora sinais vitais, nível de consciência e dor;
- Avalia curativos, drenos e sangramentos;
- Identifica precocemente sinais de complicações;
- Garante conforto, segurança e comunicação eficaz com a equipe multiprofissional;
- Registra todas as informações no prontuário.

6.3. Condução e Alta da RPA (Recuperação Pós-Anestésica)

A RPA é destinada à vigilância intensiva do paciente após o término da anestesia.

6.3.1. Condução na RPA

- Monitorização contínua dos sinais vitais, oxigenação e nível de consciência;
- Avaliação da dor, náuseas, vômitos e possíveis complicações anestésicas;
- Manutenção da via aérea e suporte ventilatório, quando necessário;
- Administração de medicações conforme prescrição;
- Aplicação de escalas de recuperação anestésica (ex.: Aldrete e Kroulik).

6.3.2. Alta da RPA

A alta ocorre após avaliação médica e de enfermagem, considerando:

- Estabilidade hemodinâmica;
- Retorno adequado da consciência e reflexos;
- Controle eficaz da dor;
- Ausência de complicações imediatas;
- Registro formal da alta e comunicação com a unidade de destino.

6.4. Descrição Cirúrgica

A descrição cirúrgica é um registro obrigatório e fundamental, devendo conter:

- Identificação do paciente e da equipe envolvida;
- Diagnóstico pré e pós-operatório;
- Procedimento realizado, técnica cirúrgica e achados intraoperatórios;
- Intercorrências, se houver;
- Contagem final de materiais;
- Condições do paciente ao término da cirurgia;
- Assinatura e identificação do cirurgião responsável.

7. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

7.1. Antes da indução anestésica

A etapa - antes da indução anestésica - requer a presença do anestesiologista e da equipe de enfermagem. Segue o detalhamento de cada um dos procedimentos desta etapa:

7.1.1. Confirmar a identificação do paciente, do sítio cirúrgico, do procedimento e do consentimento informado.

O condutor da Lista de Verificação confirma verbalmente com o paciente sua identificação, o tipo de procedimento planejado, o sítio cirúrgico e a assinatura do consentimento para cirurgia. Quando a confirmação pelo paciente não for possível, como no caso de crianças ou pacientes incapacitados, um tutor ou familiar poderá assumir esta função. Os Termos de Consentimento Informados - cirúrgicos e anestésicos - devem ser assinados pelo paciente ou seu representante legal, após os esclarecimentos feitos por médico membro da equipe cirúrgica, antes do encaminhamento do paciente para o local de realização do procedimento cirúrgico.

7.1.1. Demarcar o sítio cirúrgico

A identificação do sítio cirúrgico deverá ser realizada por médico membro da equipe cirúrgica antes do encaminhamento do paciente para o local de realização do procedimento. Sempre que possível, tal identificação deverá ser realizada com o paciente acordado e consciente, que confirmará o local da intervenção. O condutor deverá confirmar se o cirurgião fez a demarcação do local da cirurgia no corpo do paciente naqueles casos em que o procedimento cirúrgico envolve lateralidade, múltiplas estruturas ou múltiplos níveis. Nestes casos, a demarcação deverá ser realizada no corpo do paciente em local que indica a estrutura a ser operada com o uso de caneta demográfica.

O sinal de alvo deverá ser utilizado como padrão pela instituição e deve permanecer visível após preparo da pele e colocação de campos cirúrgicos. Devem-se evitar marcas ambíguas como "*x*", podendo ser utilizado, por exemplo, o para este fim.

7.1.2. Verificar a segurança anestésica

O condutor completa a próxima etapa solicitando ao anestesiologista que confirme a conclusão da verificação de segurança anestésica.

7.1.3. Verificar o funcionamento do monitor multiparamétrico

Antes da indução anestésica, o condutor confirma que um monitor multiparamétrico tenha sido posicionado no paciente e que esteja funcionando corretamente.

7.1.4. Verificar alergias conhecidas

O condutor deverá perguntar ou confirmar se o paciente possui uma alergia conhecida, mesmo se o condutor tenha conhecimento prévio a respeito da alergia. Em caso de alergia, deverá confirmar se o anestesiologista tem conhecimento e se a alergia em questão representa um risco para o paciente. Se algum membro da equipe cirúrgica tem conhecimento sobre uma alergia que o anestesiologista desconheça, esta informação deverá ser comunicada.

7.1.5. Verificar a avaliação de vias aéreas e risco de aspiração

O condutor deverá confirmar verbalmente com o anestesiologista se este avaliou objetivamente se o paciente possui uma via aérea difícil. O risco de aspiração também deverá ser levado em consideração como parte da avaliação da via aérea.

7.1.6. Verificar a avaliação de risco de perda sanguínea

O condutor deverá perguntar ao anestesiologista se o paciente tem risco de perder mais de meio litro de sangue (> 500 ml) ou mais de 7 ml/kg em crianças durante a cirurgia a fim de assegurar o reconhecimento deste risco e garantir a preparação para essa eventualidade.

7.2. Antes da incisão cirúrgica (Pausa Cirúrgica)

A Pausa Cirúrgica é uma pausa momentânea feita pela equipe imediatamente antes da incisão cutânea a fim de confirmar que as várias verificações essenciais para a segurança cirúrgica foram empreendidas e que envolveram toda equipe.

7.2.1. Identificar todos os membros da equipe

O condutor solicitará que cada pessoa na sala se apresente pelo nome e função. Nas equipes cujos membros já estão familiarizados uns com os outros, o condutor pode apenas confirmar que todos já tenham sido apresentados, mas quando ocorrer a presença de novos membros ou funcionários que tenham se revezado dentro da sala cirúrgica desde o último procedimento, estes devem se apresentar.

7.2.2. Confirmar verbalmente a identidade do paciente, o sítio cirúrgico e o procedimento.

Imediatamente antes da incisão cirúrgica, é conduzida uma nova confirmação pela equipe cirúrgica (cirurgião, anestesiologista e equipe de enfermagem) do nome do paciente e data de nascimento, do procedimento cirúrgico a ser realizado, do sítio cirúrgico, lateralidade e, quando necessário, do posicionamento do paciente.

7.2.3. Verificar a previsão de eventos críticos

O condutor da Lista de Verificação conduz uma rápida discussão com o cirurgião, anestesiologista e enfermagem a respeito de riscos graves e planejamentos operatórios.

7.2.4. Prever etapas críticas, possíveis eventos críticos, duração da cirurgia e perda sanguínea

O cirurgião deverá informar à equipe quais são as etapas críticas e os possíveis eventos críticos e a perda sanguínea prevista.

7.2.5. Revisar eventuais complicações anestésicas

O anestesiologista deverá revisar o planejamento e as preocupações específicas para ressuscitação cardiopulmonar. Deverá informar também a previsão do uso de sangue, componentes e hemoderivados, além da presença de comorbidades e características do paciente passíveis de complicação, como doença pulmonar ou cardíaca, arritmias, distúrbios hemorrágicos, etc.

7.2.6. Confirmar verbalmente a revisão das condições de esterilização, equipamentos e infraestrutura.

O instrumentador ou o técnico que disponibiliza o equipamento para a cirurgia deverá confirmar verbalmente a realização da esterilização e sua confirmação por meio do indicador de esterilização, demonstrando que a esterilização tenha sido bem-sucedida. Além de verificar se as condições dos equipamentos, bem como infraestrutura tenham sido avaliadas pela enfermagem.

7.2.7. Verificar a realização da profilaxia antimicrobiana

O condutor perguntará em voz alta se os antimicrobianos profiláticos foram administrados durante os últimos 60 minutos antes da incisão da pele. O membro da equipe responsável pela administração de antimicrobianos (geralmente o anestesiologista) deverá realizar a confirmação verbal.

7.2.8. Verificar exames de imagem

O condutor deverá perguntar ao cirurgião se exames de imagem são necessários para a cirurgia. Em caso afirmativo, o condutor deverá confirmar verbalmente que os exames necessários para realização segura do procedimento cirúrgico estão na sala e expostos de maneira adequada para uso durante a cirurgia.

7.3. Antes do paciente deixar a sala de cirurgia

7.3.1. Confirmar o nome do procedimento

O condutor deverá confirmar com o cirurgião e a equipe exatamente qual procedimento foi realizado.

7.3.2. Verificar a correta contagem de instrumentais, compressas e agulhas

O profissional de enfermagem ou o instrumentador deverá confirmar verbalmente a conclusão das contagens finais de compressas e agulhas. Nos casos de cirurgia com cavidade aberta, a conclusão da contagem de instrumental também deve ser confirmada.

7.3.3. Confirmar a identificação da amostra

O profissional de enfermagem deve confirmar a identificação/etiquetagem correta de qualquer amostra patológica obtida durante o procedimento pela leitura em voz alta do nome do paciente, descrição da amostra com indicação anatômica do local de origem da amostra e quaisquer outras indicações orientadoras.

7.3.4. Documentar problemas com equipamentos

O condutor deve assegurar que os problemas com equipamentos que tenham ocorrido durante a cirurgia sejam identificados, relatados e documentados pela equipe.

7.3.5. Rever o prontuário

O condutor deverá checar se o prontuário do paciente está completo antes de enviar à enfermaria de destino.

8. INDICADORES - ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO

- Taxa de adesão à Lista de Verificação de Cirurgia Segura;
- Taxa de Mortalidade intra-operatória;
- Taxa de adesão ao Protocolo de Profilaxia antimicrobiana.
- Incidência de erros de lateralidade/eventos adversos na cirurgia.

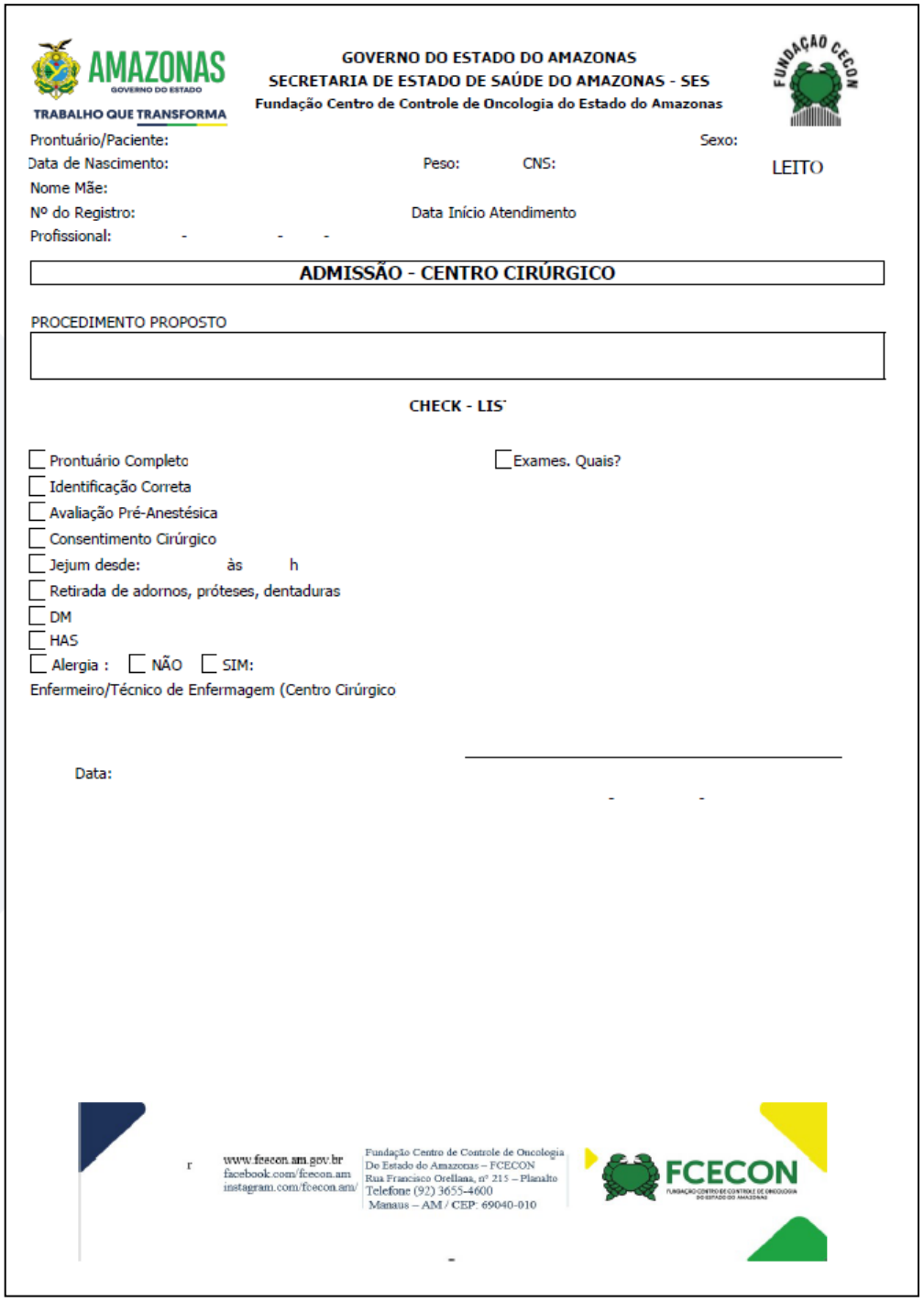
9. REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde/Anvisa/Fiocruz. PROTOCOLO PARA CIRURGIA SEGURA. Disponível em:

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/protocolo-de-cirurgia- segura. Acessado EM 13/01/2023

8. ANEXOS

A. Check List – Admissão – Centro Cirúrgico



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO
TRABALHO QUE TRANSFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SES
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas

FUNDAÇÃO CECON

Prontuário/Paciente: Sexo:
Data de Nascimento: Peso: CNS: LEITO
Nome Mãe:
Nº do Registro: Data Início Atendimento
Profissional: - - -

ADMISSÃO - CENTRO CIRÚRGICO

PROCEDIMENTO PROPOSTO

CHECK - LIS

☐ Prontuário Completo ☐ Exames. Quais?
☐ Identificação Correta
☐ Avaliação Pré-Anestésica
☐ Consentimento Cirúrgico
☐ Jejum desde: às h
☐ Retirada de adornos, próteses, dentaduras
☐ DM
☐ HAS
☐ Alergia : ☐ NÃO ☐ SIM:
Enfermeiro/Técnico de Enfermagem (Centro Cirúrgico

Data:

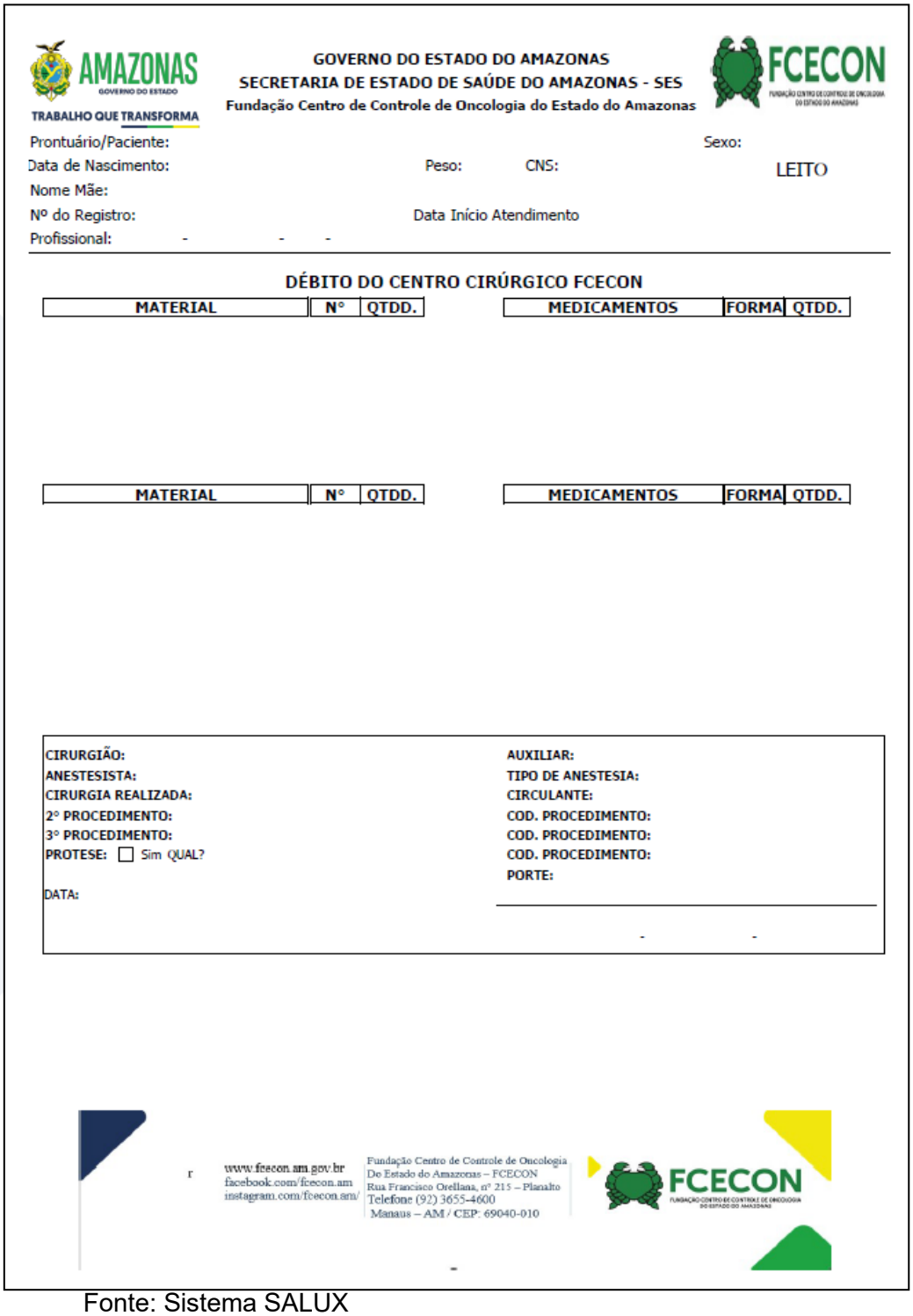
www.fcecon.am.gov.br
facebook.com/fcecon.am
instagram.com/fcecon.am/

Fundação Centro de Controle de Oncologia
Do Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana, nº 215 – Planalto
Telefone (92) 3655-4600
Manaus – AM / CEP: 69040-010

FCECON
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

Fonte: Sistema SALUX

B. Débito Do Centro Cirúrgico



AMAZONAS
TRABALHO QUE TRANSFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SES
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas

FCECON

Prontuário/Paciente: Sexo:
Data de Nascimento: Peso: CNS: LEITO
Nome Mãe:
Nº do Registro: Data Início Atendimento
Profissional: - - -

DÉBITO DO CENTRO CIRÚRGICO FCECON

MATERIAL	Nº	QTDD.	MEDICAMENTOS	FORMA	QTDD.

MATERIAL	Nº	QTDD.	MEDICAMENTOS	FORMA	QTDD.

CIRURGIÃO:
ANESTESISTA:
CIRURGIA REALIZADA:
2° PROCEDIMENTO:
3° PROCEDIMENTO:
PROTESE: ☐ Sim QUAL?

DATA:

AUXILIAR:
TIPO DE ANESTESIA:
CIRCULANTE:
COD. PROCEDIMENTO:
COD. PROCEDIMENTO:
COD. PROCEDIMENTO:
PORTE:

- -

www.fcecon.am.gov.br
facebook.com/fcecon.am
instagram.com/fcecon.am/

Fundação Centro de Controle de Oncologia
Do Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana, nº 215 – Planalto
Telefone (92) 3655-4600
Manaus – AM / CEP: 69040-010

FCECON

Fonte: Sistema SALUX

C. Registro de Enfermagem Trans Operatório

FUNDACAO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AM Página 1 de 1

CCMV037_R - **Folha de Sala**

FIA: 1014/2025 **Prontuário:** 0 **Sala:** SALA 07

Paciente: RAIMUNDO ADELSON ARCOS DE LIMA **Sexo:** Masculino **Nasc.:** 28/12/1953 **Idade:** 71 Anos

Convênio: SUS / SUS **Categoria:** Eletiva **Dt. Proced.:** 18/12/25 08:33

Enfermeiro(a): AGATHA CHRYSTINA SILVA DO NASCIMENTO **Médico Solicitante:** JORGE BARROS FREITAS

Anát. Patológico: Sim **Congelação:** Não **Qtde. Int.:** 2 **Hemoterapia:** Não

Sala de Recup.: **SR. Início:** **SR. Término:** **Total:**

Procedimento: 416010172 - RESSECCAO ENDOSCOPICA DE TUMOR VESICAL EM C **Tipo Anestesia:**

Início: 18/12/25 08:39 **Fim:** 18/12/25 09:34 **Pot. de Contaminação:** Limpa **ASA:** **Vídeo:** Não

Cirurgião: JORGE BARROS FREITAS **Início:** 18/12/25 09:00 **Fim:** 18/12/25 09:27 **Anest.:** MEWRYANE CAMARA BRANDAO RAM

Auxiliar 1: **Auxiliar 2:**

Auxiliar 3: **Pediatra:**

Circulante: KAREN CRISTINE FERREIRA BENCHAYA **Instrumentador:**

ITENS

Cód.	Materiais	Unid.	Qtd.
27001	PRODUTOS CENTRO CIRURGICO	UN	1

CIRURGIÃO: JORGE BARROS FREITAS
CRM: 8657

ANESTESISTA: MEWRYANE CAMARA BRANDAO RAMOS
CRM: 8796

ENFERMEIRO: AGATHA CHRYSTINA SILVA DO NASCIMENTO

Fonte: Sistema SALUX

D. Check List Antes da Indução Anestésica e Chck In Antes da Incisão Cirúrgica e Antes do Paciente sair da Sala Operatória

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
TRABALHO QUE TRANSFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SES
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas

FCECON

Prontuário/Paciente: Sexo:
Data de Nascimento: Peso: CNS: LEITO
Nome Mãe:
Nº do Registro: Data Início Atendimento
Profissional: - - -

CHECK-LIST : ANTES DA INDUÇÃO ANESTÉSICA

- ☐ Confirmar com o paciente (nome completo) se não verbalizar confirme em outra fonte
- ☐ Confirmar o procedimento e local da cirurgia (com cirurgião, prontuário).
- ☐ Confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e sua demarcação.
- ☐ Paciente monitorizado (monitor multiparamétrico)
- ☐ Confirmado com banco de sangue presença de hemoderivados conforme necessidade e solicitaçã
- ☐ Risco de perda sanguínea
- ☐ Confirmar com anestesia se o paciente tem via áerea difícil (providenciar material).
- ☐ Antibioticoterapia em SC ☐ Enfermaria ☐ Qual antibiótico?
- ☐ Necessidade de reserva de UTI
- ☐ Equipamentos, Materiais e Medicamentos certos: (conforme solicitados antecipadamente
- ☐ Documentação Certa: Anamnese, exame físico, Avaliação pré-anestésica, termo de consentimento cirúrgico, exames complementares e de Imagem).
- ☐ Confirmar tempo de duração prevista para a cirurgia.
- ☐ Faltando algum material qual?

OBS:

CHECK-IN : ANTES DA INCISÃO CIRÚRGICA

- ☐ Equipe cirúrgico presente.
- ☐ Paciente está em posição certa para o procedimento.
- ☐ Confirmar o procedimento a ser realizado/lateralidade.
- ☐ Confirmar a administração do antibiótico. Qual antibiótico/dosager
- ☐ Alguma preocupação especifica com paciente. Qual

CHECK-IN : ANTES DO PACIENTE SAIR DA SALA OPERATÓRIA

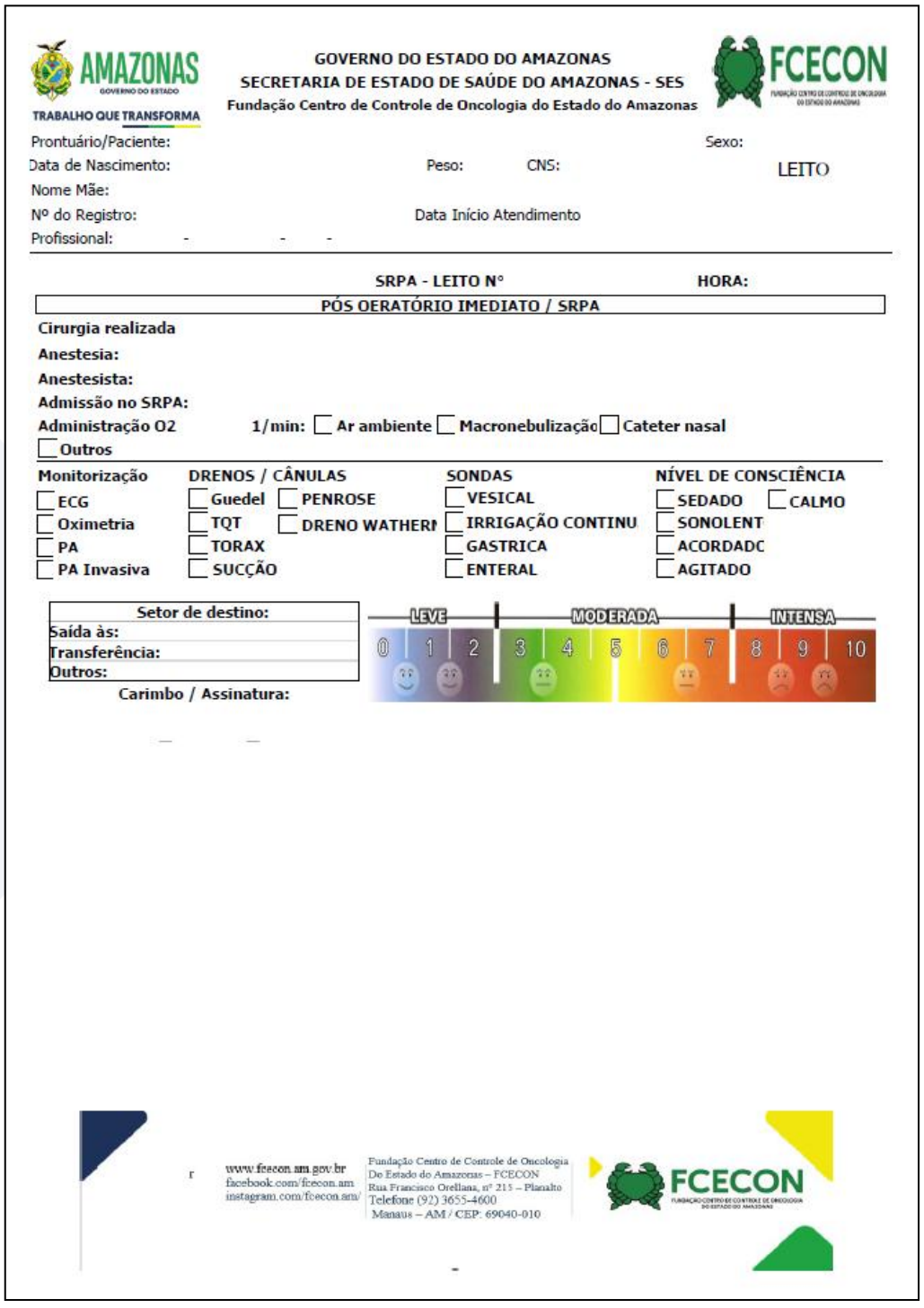
- ☐ Saiu o procedimento previsto inicialmente? Se não, Qual
- ☐ Contagem de compressas e instrumentais
- ☐ Teve peça anatomopatológica. Qual:

www.fcecon.am.gov.br
facebook.com/fcecon.am
instagram.com/fcecon.am/
Fundação Centro de Controle de Oncologia
De Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana, nº 215 – Planalto
Telefone (92) 3655-4600

FCECON

Fonte: Sistema SALUX

E. Check List – Recuperação Pós Anestésica – SRPA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO
TRABALHO QUE TRANSFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SES
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas

FCECON

Prontuário/Paciente: Sexo:
Data de Nascimento: Peso: CNS: LEITO
Nome Mãe:
Nº do Registro: Data Início Atendimento
Profissional: - - -

SRPA - LEITO N° HORA:

PÓS OERATÓRIO IMEDIATO / SRPA

Cirurgia realizada
Anestesia:
Anestesista:
Admissão no SRPA:
Administração O2 1/min: ☐ Ar ambiente ☐ Macronebulização ☐ Cateter nasal
☐ Outros

Monitorização	DRENOS / CÂNULAS		SONDAS	NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	
☐ ECG	☐ Guedel	☐ PENROSE	☐ VESICAL	☐ SEDADO	☐ CALMO
☐ Oximetria	☐ TQT	☐ DRENO WATHERI	☐ IRRIGAÇÃO CONTINU	☐ SONOLENT	
☐ PA	☐ TORAX		☐ GASTRICA	☐ ACORDADC	
☐ PA Invasiva	☐ SUCÇÃO		☐ ENTERAL	☐ AGITADO	

Setor de destino:
Saída às:
Transferência:
Outros:

Carimbo / Assinatura:

LEVE MODERADA INTENSA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

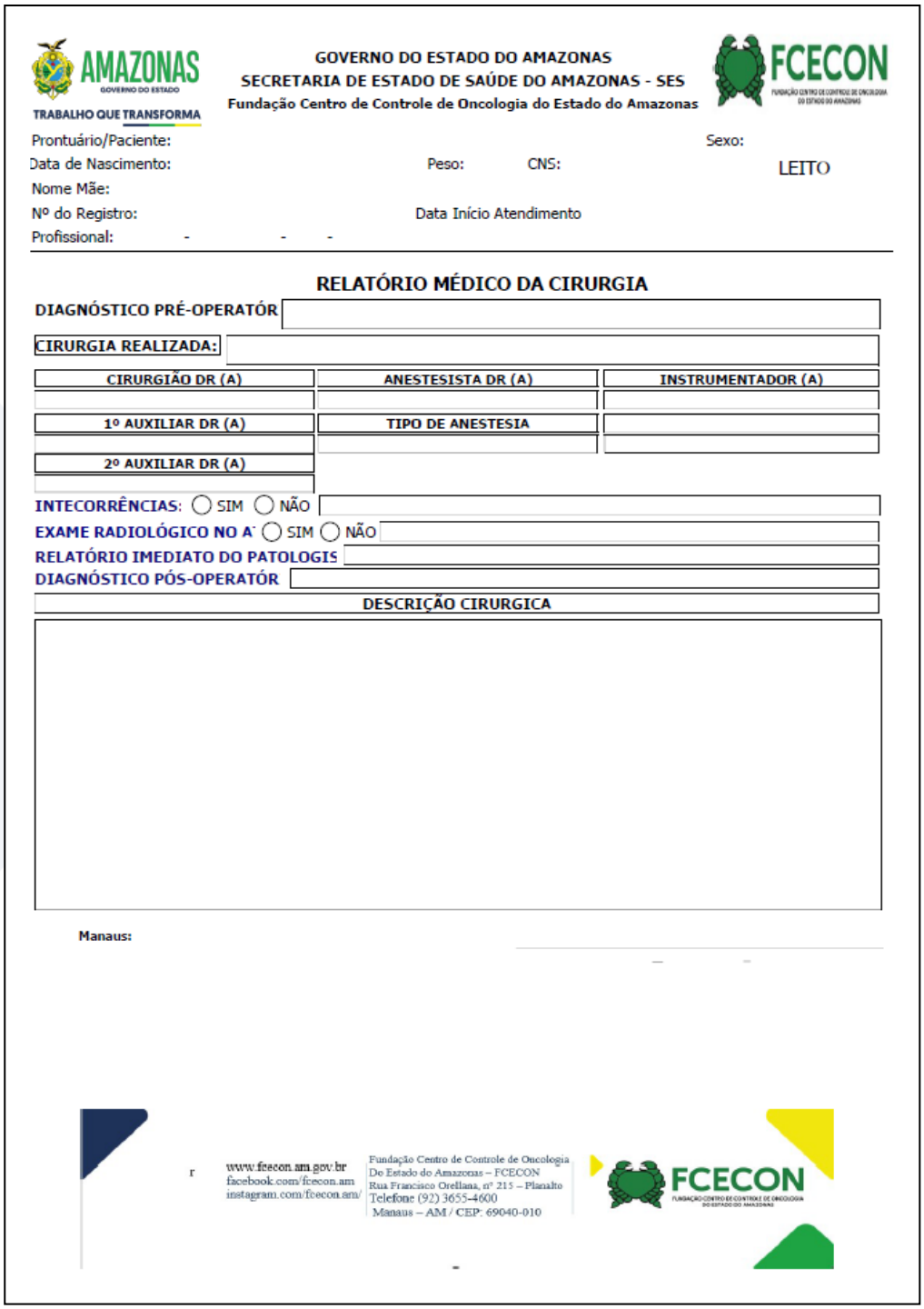
www.fcecon.am.gov.br
facebook.com/fcecon.am
instagram.com/fcecon.am/

Fundação Centro de Controle de Oncologia
De Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana, nº 215 – Planalto
Telefone (92) 3655-4600
Manaus – AM / CEP: 69040-010

FCECON

Fonte: Sistema SALUX

F. Relatório Médico da Cirúrgia



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SES
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas

TRABALHO QUE TRANSFORMA

Prontuário/Paciente: Sexo:
Data de Nascimento: Peso: CNS: LEITO
Nome Mãe:
Nº do Registro: Data Início Atendimento
Profissional: - - -

RELATÓRIO MÉDICO DA CIRURGIA

DIAGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓR
CIRURGIA REALIZADA:

CIRURGIÃO DR (A)	ANESTESISTA DR (A)	INSTRUMENTADOR (A)
1º AUXILIAR DR (A)	TIPO DE ANESTESIA	
2º AUXILIAR DR (A)		

INTECORRÊNCIAS: ◯ SIM ◯ NÃO
EXAME RADIOLÓGICO NO A ◯ SIM ◯ NÃO
RELATÓRIO IMEDIATO DO PATOLOGIS
DIAGNÓSTICO PÓS-OPERATÓR

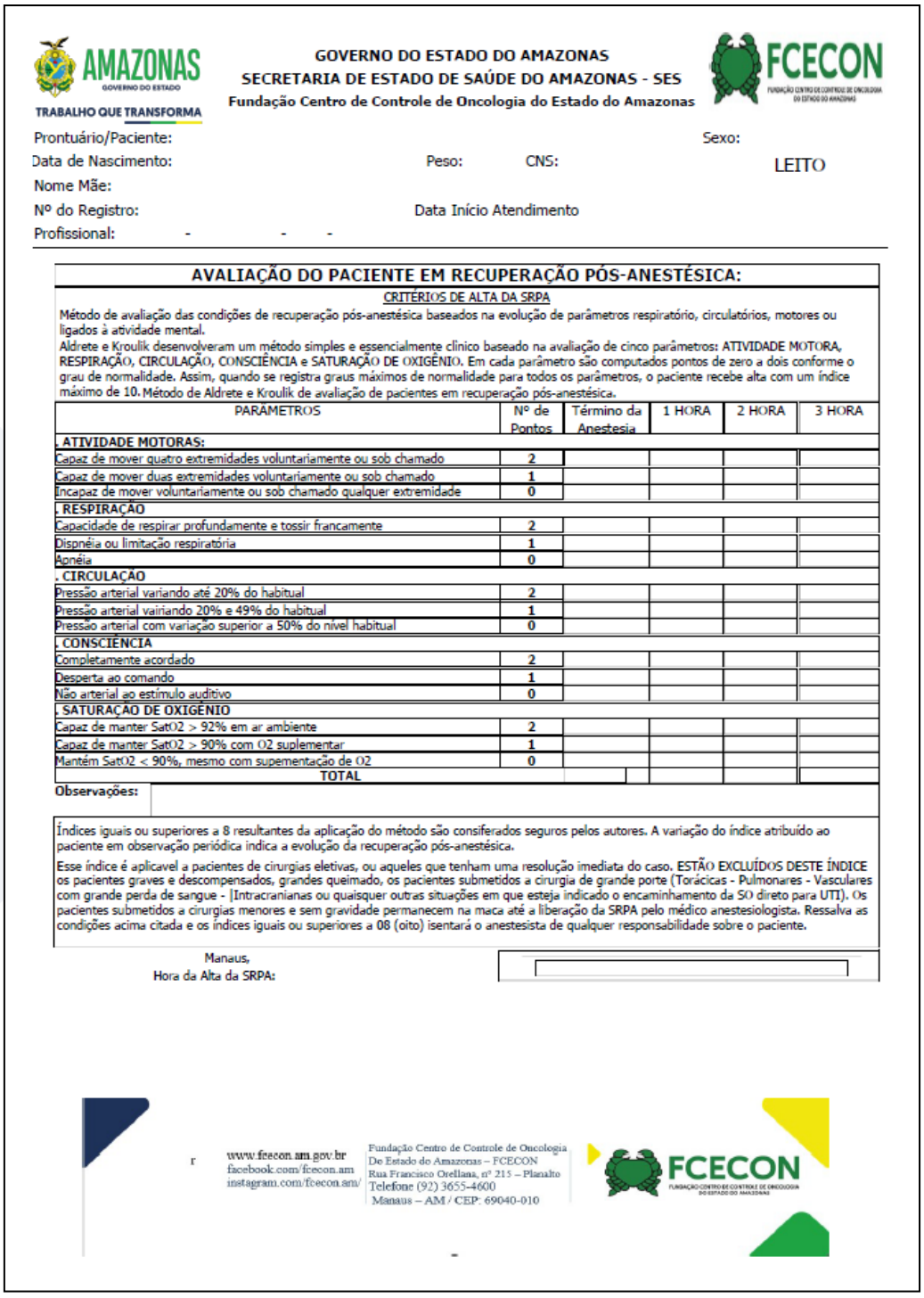
DESCRIÇÃO CIRURGICA

Manaus:

www.fcecon.am.gov.br
facebook.com/fcecon.am
instagram.com/fcecon.am/
Fundação Centro de Controle de Oncologia
Do Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana, nº 215 – Planalto
Telefone (92) 3655-4600
Manaus – AM / CEP: 69040-010

Fonte: Sistema SALUX

G. Avaliação do Paciente em Recuperação Pós-Anestésica



AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
TRABALHO QUE TRANSFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SES
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas

FCECON

Prontuário/Paciente: Sexo:
Data de Nascimento: Peso: CNS: LEITO
Nome Mãe:
Nº do Registro: Data Início Atendimento
Profissional: - - -

AVALIAÇÃO DO PACIENTE EM RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA:

CRITÉRIOS DE ALTA DA SRPA

Método de avaliação das condições de recuperação pós-anestésica baseados na evolução de parâmetros respiratório, circulatórios, motores ou ligados à atividade mental.
Aldrete e Kroulik desenvolveram um método simples e essencialmente clínico baseado na avaliação de cinco parâmetros: ATIVIDADE MOTORA, RESPIRAÇÃO, CIRCULAÇÃO, CONSCIÊNCIA e SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO. Em cada parâmetro são computados pontos de zero a dois conforme o grau de normalidade. Assim, quando se registra graus máximos de normalidade para todos os parâmetros, o paciente recebe alta com um índice máximo de 10. Método de Aldrete e Kroulik de avaliação de pacientes em recuperação pós-anestésica.

PARÂMETROS	Nº de Pontos	Término da Anestesia	1 HORA	2 HORA	3 HORA
. ATIVIDADE MOTORAS:					
Capaz de mover quatro extremidades voluntariamente ou sob chamado	2				
Capaz de mover duas extremidades voluntariamente ou sob chamado	1				
Incapaz de mover voluntariamente ou sob chamado qualquer extremidade	0				
. RESPIRAÇÃO					
Capacidade de respirar profundamente e tossir francamente	2				
Dispnéia ou limitação respiratória	1				
Apnéia	0				
. CIRCULAÇÃO					
Pressão arterial variando até 20% do habitual	2				
Pressão arterial variando 20% e 49% do habitual	1				
Pressão arterial com variação superior a 50% do nível habitual	0				
. CONSCIÊNCIA					
Completamente acordado	2				
Desperta ao comando	1				
Não arterial ao estímulo auditivo	0				
. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO					
Capaz de manter SatO2 > 92% em ar ambiente	2				
Capaz de manter SatO2 > 90% com O2 suplementar	1				
Mantém SatO2 < 90%, mesmo com supementação de O2	0				
TOTAL					

Observações:

Índices iguais ou superiores a 8 resultantes da aplicação do método são consiferados seguros pelos autores. A variação do índice atribuído ao paciente em observação periódica indica a evolução da recuperação pós-anestésica.

Esse índice é aplicavel a pacientes de cirurgias eletivas, ou aqueles que tenham uma resolução imediata do caso. ESTÃO EXCLUÍDOS DESTE ÍNDICE os pacientes graves e descompensados, grandes queimado, os pacientes submetidos a cirurgia de grande porte (Torácicas - Pulmonares - Vasculares com grande perda de sangue - Intracranianas ou quaisquer outras situações em que esteja indicado o encaminhamento da SO direto para UTI). Os pacientes submetidos a cirurgias menores e sem gravidade permanecem na maca até a liberação da SRPA pelo médico anestesiologista. Ressalva as condições acima citada e os índices iguais ou superiores a 08 (oito) isentará o anestesista de qualquer responsabilidade sobre o paciente.

Manaus,
Hora da Alta da SRPA:

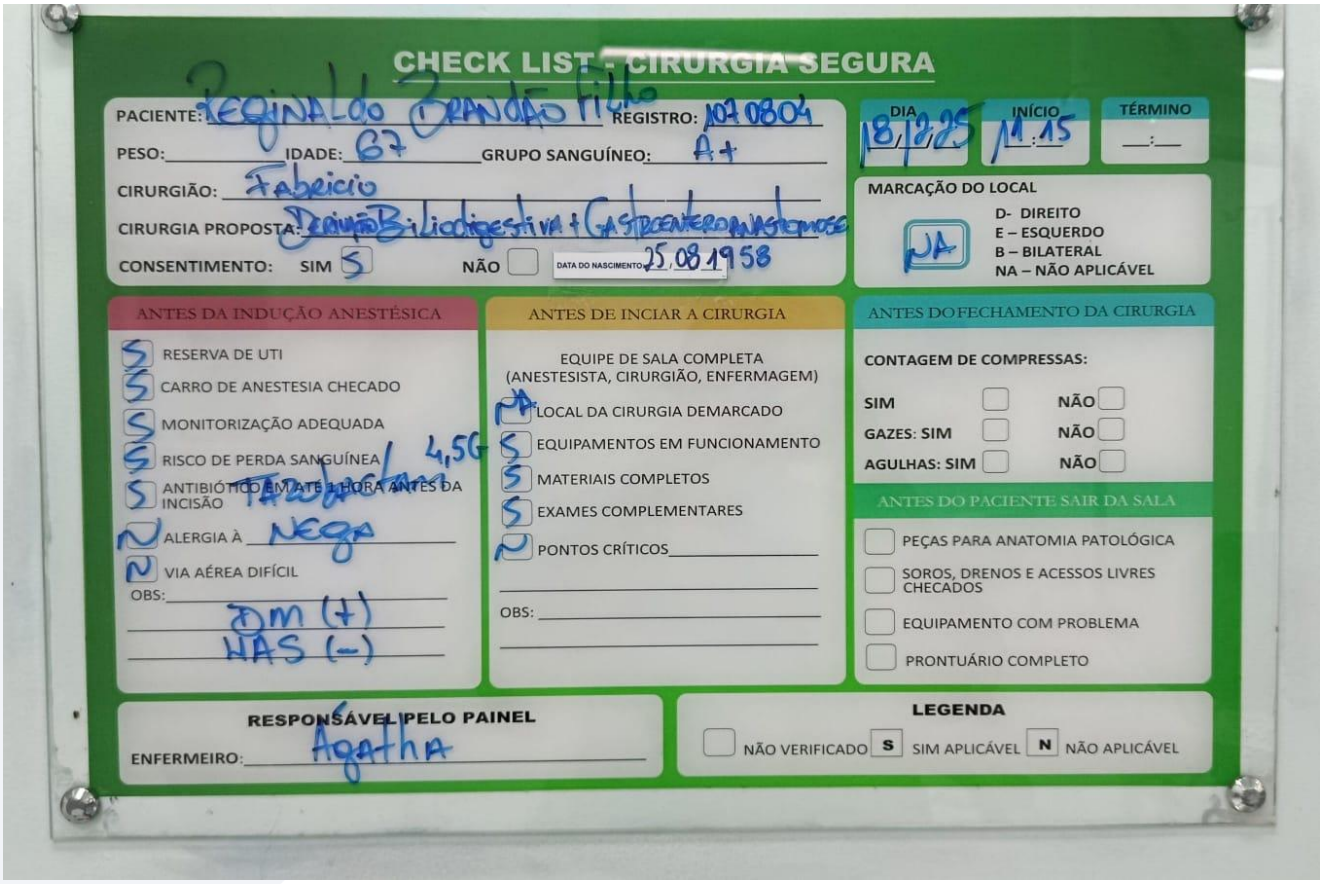
www.fcecon.am.gov.br
facebook.com/fcecon.am
instagram.com/fcecon.am/

Fundação Centro de Controle de Oncologia
Do Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana, nº 215 – Planalto
Telefone (92) 3655-4600
Manaus – AM / CEP: 69040-010

FCECON

Fonte: Sistema SALUX

E. Quadro de Check List – Cirurgia Segura



CHECK LIST - CIRURGIA SEGURA

PACIENTE: REGINALDO BRANDÃO FILHO REGISTRO: 1070804
PESO: IDADE: 67 GRUPO SANGUÍNEO: A+
CIRURGIÃO: Fabricio
CIRURGIA PROPOSTA: Derivação Bilio digestiva + Gastroenteroanastomose
CONSENTIMENTO: SIM S NÃO DATA DO NASCIMENTO 25/08/1958

DIA 18/12/25 INÍCIO 11:15 TÉRMINO __:__

MARCAÇÃO DO LOCAL: JA
D- DIREITO
E – ESQUERDO
B – BILATERAL
NA – NÃO APLICÁVEL

ANTES DA INDUÇÃO ANESTÉSICA
S RESERVA DE UTI
S CARRO DE ANESTESIA CHECADO
S MONITORIZAÇÃO ADEQUADA
S RISCO DE PERDA SANGUÍNEA
S ANTIBIÓTICO EM ATÉ 1 HORA ANTES DA INCISÃO Tazocin 4,5G
N ALERGIA À NEGA
N VIA AÉREA DIFÍCIL
OBS: DM (+) HAS (-)

ANTES DE INCIAR A CIRURGIA
EQUIPE DE SALA COMPLETA (ANESTESISTA, CIRURGIÃO, ENFERMAGEM)
NA LOCAL DA CIRURGIA DEMARCADO
S EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO
S MATERIAIS COMPLETOS
S EXAMES COMPLEMENTARES
N PONTOS CRÍTICOS
OBS:

ANTES DO FECHAMENTO DA CIRURGIA
CONTAGEM DE COMPRESSAS:
SIM NÃO
GAZES: SIM NÃO
AGULHAS: SIM NÃO

ANTES DO PACIENTE SAIR DA SALA
PEÇAS PARA ANATOMIA PATOLÓGICA
SOROS, DRENOS E ACESSOS LIVRES CHECADOS
EQUIPAMENTO COM PROBLEMA
PRONTUÁRIO COMPLETO

RESPONSÁVEL PELO PAINEL
ENFERMEIRO: Agatha

LEGENDA
NÃO VERIFICADO S SIM APLICÁVEL N NÃO APLICÁVEL

9. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	10/12/2025	Elaboração do Protocolo da Meta 4 – Cirurgia Segura

Elaboração: ANDREA LIMA DE SOUZA MARQUES:49400991215 Assinado de forma digital por ANDREA LIMA DE SOUZA MARQUES:49400991215 Dados: 2025.12.19 11:05:59 -04'00' **Coordenação do Núcleo de Segurança do Paciente** Andréa Lima de Souza Marques	**Data:** 10/12/2025
Revisão:	**Data:**
Aprovação: HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 Assinado de forma digital por HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 **Diretora Técnica** Hilka Flávia Barra do Espírito Santo Alves Pereira	**Data:**